

TEMA 3.26 • OBSTETRICIA

Prevención de la Preeclampsia

PERFIL EUNACOM 2.01.2.020

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Prevención de la Preeclampsia

Tratamiento Preventivo: Aspirina en Dosis Baja

Dosis: 81–100 mg/día

Rango de EG: Desde las 12 semanas hasta las 36 semanas

(Algunas fuentes: desde 16 sem; se suspende antes del parto para evitar sangrado)

Indicaciones de Aspirina Profiláctica

Factores de riesgo ALTO (1 solo ya indica aspirina)

TABLA 3.26.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS
FACTOR DE RIESGO ALTO
Preeclampsia previa
HTA crónica
Nefropatía
Embarazo gemelar
Diabetes mellitus pregestacional (no gestacional)
Lupus eritematoso sistémico (LES)
Síndrome antifosfolípido (SAF)

Factores de riesgo MODERADO (2 o más indican aspirina)

TABLA 3.26.2: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS
FACTOR DE RIESGO MODERADO
Nuliparidad
Obesidad
Antecedente familiar (1er grado) de PE
Edad > 35 años

Doppler de Arterias Uterinas

- Si la resistencia de arterias uterinas está aumentada → es predictor de riesgo de PE
- Recomendación: aspirina si Doppler uterino alterado
- Evidencia débil — varias guías no lo recomiendan explícitamente para este fin

NOTA CLÍNICA

El Doppler de **arterias uterinas** (materno) es el **predictor de preeclampsia**. No confundir con el Doppler de arteria **umbilical** (fetal), que evalúa RCIU.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 32 semanas de gestación con PA 158/105 mmHg en dos mediciones, proteinuria de 500 mg en orina de 24h y cefalea intensa. ¿Diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Prevención de la Preeclampsia. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Tratamiento Preventivo: Aspirina en Dosis Baja
- Indicaciones de Aspirina Profiláctica
- Factores de riesgo ALTO (1 solo ya indica aspirina)
- Factores de riesgo MODERADO (2 o más indican aspirina)
- Doppler de Arterias Uterinas
- Diabetes mellitus pregestacional
- Lupus eritematoso sistémico (LES)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PREVENCIÓN DE LA PREECLAMPSIA)

PREGUNTA 1

Mujer de 32 semanas de gestación con PA 158/105 mmHg en dos mediciones, proteinuria de 500 mg en orina de 24h y cefalea intensa. ¿Diagnóstico?

- ☐ A) Hipertensión gestacional sin proteinuria
- ☐ B) Preeclampsia con criterios de severidad
- ☐ C) Hipertensión crónica agravada
- ☐ D) Eclampsia
- ☐ E) Síndrome de bata blanca — repetir en casa

PREGUNTA 2

¿Cuál es el tratamiento de elección para prevenir las convulsiones (eclampsia) en una paciente con preeclampsia grave?

- ☐ A) Nifedipino oral para bajar la presión
- ☐ B) Sulfato de magnesio IV
- ☐ C) Fenobarbital IM
- ☐ D) Diazepam IV en bolo
- ☐ E) Corticoides para maduración pulmonar fetal

PREGUNTA 3

¿Cuál es el único tratamiento definitivo de la preeclampsia?

- ☐ A) Antihipertensivos de por vida
- ☐ B) Reposo absoluto hasta el término
- ☐ C) Interrupción del embarazo (parto)
- ☐ D) Hemodiálisis para eliminar los factores vasopresores
- ☐ E) Ácido acetilsalicílico a dosis antiagregante

RESUMEN: PREVENCIÓN DE LA PREECLAMPSIA

:::note El Doppler de arterias uterinas (materno) es el predictor de preeclampsia. No confundir con el Doppler de arteria umbilical (fetal), que evalúa RCIU. :::